

RECURSO CÍVEL Nº 5005474-46.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: VERA LUCIA SERENO DA SILVA (AUTOR)

ADVOGADO(A): ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5005474-46.2024.4.02.5006

500003662072 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005474-46.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: VERA LUCIA SERENO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada.

2. Em suas razões, alega que sofre de doenças ortopédicas que lhe impõem limitações à plena participação na vida social. Ao final, pede a reforma da sentença.

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A sentença julgou o pedido nos seguintes termos:

Do caso concreto

*No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência da parte autora (**evento 1, PROCADM10**). Por tal razão, foi realizada perícia médico-judicial, conforme laudo do **evento 23, LAUDPER11**.*

O perito, médico especialista em ortopedia, constatou que o(a) autor(a) não possui deficiência. Complementou que:

Periciada lúcida e orientada no tempo e espaço, respondendo bem às solicitações com boa aparência e condições de higiene.

Humor sem alterações, com concentração mantida e colaborativa.

IMC 31,84 - Obesidade.

Marcha sem apoio e sem auxílio.

Cicatriz cirurgica em face anterior do joelho esquerdo de 8 cm (entrada da haste) outra medial do tornozelo esquerdo de 9cm (colocação de placa).

cicatriz irregular grande em face lateral da perna direita em 1/3 proximal.

Mobildidade completa dos joelhos com força preservada nas pernas e pés.

Queixa dor a mobilização da coluna cervical e lombar, sem sinais de compressão radicular.

Diagnóstico/CID:

- M15.0 - (Osteo)artrose primária generalizada

- S82.2 - Fratura da diáfise da tíbia

- S72.3 - Fratura da diáfise do fêmur

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não se confunde com a de um médico assistente responsável pelo tratamento da parte. Sua função precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir que o perito

tenha ou não determinada especialidade médica relacionada com a moléstia apresentada, melhor seria dele exigir a técnica necessária para atuar como perito, porquanto distinto é o médico que trata daquele que pericia.

Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo magistrado.

Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que carregam os autos, convenço-me de que não é possível enquadrar tais patologias, no atual grau, no conceito legal de deficiência, conforme art. 20, §2º, da Lei 8.742/93.

Neste eito, considerando que a parte autora não preenche um dos requisitos da lei para concessão do benefício assistencial, porquanto não apresenta impedimentos de longo prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de deficiência se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

5. Esclareça-se que à luz do Enunciado n. 67 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo:

O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexistente impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente.

6. Conforme consignado na sentença, a perícia médica judicial atestou que, embora a autora sofresse de doenças ortopédicas, ela não se enquadrava no conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 20, §§ 2º e 10, da Lei n. 8.742/1993, em consonância com o laudo da perícia médica administrativa (ev. 1, PROCADM10, fl. 23).

7. Para infirmar o laudo pericial, a autora deveria apresentar prova robusta de que preenche o requisito da deficiência - enfatize-se - no sentido do art. 20, §§ 2º e 10, da Lei n. 8.742/1993. No entanto, os documentos médicos particulares de ev. 1, LAUDO7, LAUDO8, LAUDO9 e ev. 22, LAUDO1 e LAUDO2, não afirmam que o estado de saúde da autora configura um quadro de deficiência. Assim, esses documentos médicos não são aptos para infirmar a conclusão da perícia médica judicial, acolhida pela sentença.

8. Como a parte autora, em suas razões, não apresentou elementos capazes de justificar a reforma da sentença, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, "caput", da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da autora.